



[Accueil](#) > [Particuliers](#) > [Soins de santé en France](#) > Le système de santé en France

Le système de santé en France

2021

Le système de santé français s'appuie sur des structures multiples : ambulatoires pour les soins dits « de ville », sanitaires pour la prise en charge hospitalière et médico-sociales et sociales pour des publics dits « fragiles », âgés ou handicapés. Il repose sur la liberté de choix du patient et du résident : chaque patient est libre de choisir son médecin traitant, un spécialiste en accès direct, son établissement de santé, sa structure d'hébergement, ceci dans le secteur public comme dans le secteur privé.

L'Assurance maladie couvre la prise en charge des prestations suivantes si elles sont inscrites à la nomenclature des prestations remboursables :

- les soins et traitements hospitaliers dans les établissements publics ou privés de santé, de réadaptation ou de rééducation ;
- les soins ambulatoires dispensés par les médecins généralistes, les spécialistes, les dentistes et les sages-femmes ;
- les examens diagnostiques et les soins prescrits par les médecins et effectués par les laboratoires d'analyses et les professionnels paramédicaux (infirmières, physiothérapeutes, orthophonistes, etc.) ;
- les médicaments, les appareils médicaux et les prothèses prescrits par ordonnance et figurant sur les listes de produits remboursables ;
- les transports sanitaires prescrits par ordonnance.

[D'autres informations relatives au régime de sécurité sociale français et à son financement ainsi qu'aux conditions de prise en charge des soins figurent sur le site du CLEISS.](#)

I. Les acteurs et le pilotage du système de santé

- [Au niveau national : les ministères](#)
- [Au niveau régional : les ARS](#)
- [Les agences ou établissements de l'État](#)
- [Les régimes d'assurance maladie](#)
- [Les ordres et syndicats de professionnels de santé](#)
- [Les bénéficiaires du système de santé, via les associations de patients](#)

II. L'organisation des soins

- [La santé publique](#)
- [Les soins ambulatoires](#)
- [Les soins hospitaliers](#)
- [Les soins d'urgence](#)
- [Les soins de longue durée](#)
- [Les pharmacies](#)

III. Les coordonnées des différents prestataires de santé

IV. Le financement du système de soins

- [Les régimes d'assurance maladie obligatoire de base](#)
- [Les régimes complémentaires \(mutuelles, sociétés d'assurances, institutions de prévoyance\)](#)
- [Les financeurs publics \(État\)](#)
- [Les ménages](#)

V. La surveillance des professionnels de santé

- [Les Agences régionales de santé \(ARS\)](#)
- [La Haute Autorité de santé \(HAS\)](#)
- [L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé \(ANSM\)](#)
- [L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail \(ANSES\)](#)
- [L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire \(IRSN\)](#)

I. Les acteurs et le pilotage du système de santé

a) Au niveau national : les ministères

L'État intervient directement dans le financement et l'organisation de l'offre sanitaire et médico-sociale. À ce titre, les ministères chargés de la santé, de l'action et des comptes publics assument un large éventail de responsabilités, parmi lesquelles :

- **le pilotage et la mise en œuvre des politiques de santé publique, de veille et de sécurité sanitaire** afin de préserver et d'améliorer l'état de santé de la population par la prévention des maladies chroniques, la lutte contre les risques infectieux ou environnementaux, et de la protéger des menaces sanitaires. Pour y parvenir, les ministères s'appuient sur les agences sanitaires (Santé publique France, Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux), opérateurs publics dont ils assurent la tutelle, ainsi que sur des partenaires indépendants tels que la Haute Autorité de Santé (HAS).
- **la supervision de l'ensemble des établissements de soins et d'accompagnement, la formation des professionnels de santé.** L'État veille à une bonne répartition des structures sanitaires, médico-sociales et ambulatoires sur le territoire national. Il veille également à la complémentarité efficace des professionnels de ces structures, afin d'offrir une réponse adaptée et de proximité aux besoins de santé de la population dans chaque territoire.
- **le soutien financier aux établissements sanitaires et médico-sociaux, la fixation des tarifs de prestation et la maîtrise des coûts en santé, la tutelle des organismes d'assurance maladie.** Chaque année, le parlement vote la loi de financement de la sécurité sociale : elle définit l'objectif national de dépenses d'assurance maladie qui intègre les soins de ville, hospitaliers et médico-sociaux. À partir de ces montants budgétaires et en fonction des orientations du gouvernement, les ministères élaborent leurs politiques en vue de leur mise en œuvre : santé publique, offre de soins.

Les principales actions du Ministère de la santé consistent à :

- répartir les budgets entre les différents secteurs : hôpitaux, soins ambulatoires, santé mentale, secteur sanitaire et social pour les personnes atteintes d'un handicap et les personnes âgées et, en ce qui concerne les hôpitaux, entre les différentes régions ;
- décider du nombre de lits d'hôpitaux et de la quantité d'équipements médicaux lourds, y compris les technologies médicales coûteuses ;
- fixer les tarifs forfaitaires des hôpitaux publics et privés ;
- approuver les accords signés entre l'Assurance maladie et les syndicats représentant les professionnels de santé libéraux ;
- fixer les prix des médicaments et des dispositifs médicaux sur la base des propositions de la Haute Autorité de Santé (HAS) ;
- établir des normes de sécurité pour les hôpitaux ;
- définir les domaines prioritaires des programmes de santé nationaux.

Par ailleurs, des corps de contrôle tels que la Cour des Comptes ou l'Inspection générale des Affaires Sociales (IGAS) vérifient l'exécution de la loi de financement de la sécurité sociale.

b) Au niveau régional : les ARS

Les agences régionales de santé assurent la coordination de la prévention, des soins et de l'accompagnement. Elles veillent à une gestion cohérente des ressources pour permettre un accès égal de tous à une prise en charge continue, de qualité et sécurisée.

- **En matière de prévention : elles mettent en œuvre au niveau régional la politique de santé** en liaison avec les autorités compétentes dans les domaines de la santé au travail, de la santé scolaire et universitaire, et de la protection maternelle et infantile. À ce titre :
 - elles organisent l'observation de la santé dans la région, et la veille sanitaire, en particulier le recueil, la transmission et le traitement des signalements d'événements sanitaires ;
 - elles contribuent à l'organisation de la réponse aux urgences sanitaires et à la gestion des situations de crise sanitaire ;
 - elles établissent un programme annuel de contrôle du respect des règles d'hygiène (prélèvements, analyses et vérifications) et procèdent aux inspections nécessaires ;
 - elles définissent et financent des actions visant à promouvoir la santé, à informer et à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d'autonomie, et elles veillent à leur évaluation.
- **En matière de soins et d'accompagnement : elles régulent, orientent et organisent l'offre de services de santé**, de manière à répondre aux besoins en matière de prévention, de promotion de la santé, de soins et de services médico-sociaux, et à garantir l'efficacité du système de santé. À ce titre :
 - elles contribuent à **évaluer et à promouvoir les formations des professionnels de santé**, des acteurs de la prévention de la santé, des personnels qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes atteintes d'un handicap ou dans les établissements une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que les formations des aidants et des accueillants familiaux ;
 - elles autorisent la création et les activités des établissements de santé, et des établissements et services médico-sociaux ; elles contrôlent leur fonctionnement et leur allouent les ressources qui relèvent de leur compétence ;

- elles veillent à ce que la répartition territoriale de l'offre de prévention, de promotion de la santé, de soins et médico-sociale permette de satisfaire les besoins de santé de la population, elles contribuent à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé et assurent la mise en place du projet territorial de santé mentale ;
- elles contribuent à mettre en œuvre un service unique d'aide à l'installation des professionnels de santé ;
- elles veillent à la **qualité des interventions en matière de prévention, de promotion de la santé, à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la dispensation et de l'utilisation des produits de santé ainsi que des prises en charge et accompagnements médico-sociaux** et elles procèdent à des contrôles à cette fin ; elles contribuent à la lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance dans les établissements et services de santé et médico-sociaux ;
- elles veillent à assurer l'accès à la prévention, à la promotion de la santé, aux soins de santé et aux services psycho-sociaux des personnes en situation de précarité ou d'exclusion ;
- elles définissent et **mettent en œuvre les actions régionales déclinant le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins** ou le complétant. Ces actions portent sur le **contrôle et l'amélioration des modalités de recours aux soins et des pratiques des professionnels de santé en médecine ambulatoire et dans les établissements et services de santé et médico-sociaux** ;
- elles encouragent et favorisent, au sein des établissements, l'élaboration et la mise en œuvre d'un volet culturel ;
- elles évaluent et identifient les besoins sanitaires des personnes en détention. Elles définissent et régulent l'offre de soins en milieu pénitentiaire ;
- elles sont chargées d'organiser les fonctions d'appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes ;
- elles favorisent des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l'appropriation des outils de prévention et d'éducation à la santé ;
- elles participent, en lien avec les universités et les collectivités territoriales concernées, à l'analyse des besoins et de l'offre en matière de formation pour les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ;
- elles s'associent avec l'ensemble des acteurs de santé, les universités, les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou tout autre organisme de recherche pour participer à l'organisation territoriale de la recherche en santé ;
- dans le respect des engagements internationaux de la France et en accord avec les autorités compétentes de l'État, elles sont autorisées à développer des actions de coopération internationale en vue de promouvoir les échanges de bonnes pratiques avec leurs partenaires étrangers.

Ainsi, les ARS déclinent les politiques nationales et les adaptent à leurs caractéristiques régionales (démographiques, épidémiologiques, géographiques) en établissant des programmes régionaux de santé (PRS), composés de :

- schémas régionaux de prévention,
- schémas d'organisation des soins de ville et hospitaliers,
- schémas régionaux d'organisation médico-sociale pour les personnes âgées ou dépendantes, atteintes d'un handicap, en situation de précarité.

Lutter contre les inégalités, améliorer la répartition locale de l'offre de soins et médico-sociale, et mieux adapter les réponses aux spécificités et aux besoins locaux constituent les objectifs des services régionaux.

c) Les agences ou établissements de l'État

L'Agence de biomédecine est une agence publique nationale de l'État créée par la loi de bioéthique. L'Agence exerce ses missions dans les domaines du prélèvement et de la greffe d'organes, de tissus et de cellules, ainsi que dans les domaines de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines. Elle est l'autorité de référence sur les aspects médicaux, scientifiques et éthiques relatifs à ces questions.

Ses missions consistent à :

- suivre, évaluer et contrôler les activités thérapeutiques et biologiques relevant de ses compétences, veiller à leur transparence et participer à l'élaboration de la réglementation des activités relevant de ses prérogatives ;
- délivrer les autorisations pour les recherches in vitro sur l'embryon et les cellules embryonnaires et pour la conservation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherches ;
- autoriser les échanges de cellules reproductives et de cellules souches embryonnaires avec des pays tiers destinés à la recherche ;
- délivrer des autorisations aux centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et aux centres de diagnostic préimplantatoire ;
- agréer les praticiens réalisant de l'assistance médicale à la procréation, du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire, des examens des caractéristiques génétiques ;

- gérer l'ensemble des activités en matière de prélèvement et de greffe ;
- gérer le registre national des volontaires au don de moelle osseuse ;
- gérer, avec toutes les garanties requises, les fichiers nécessaires à la gestion et au suivi des activités thérapeutiques relevant de sa compétence ;
- promouvoir le don d'organes, de tissus et de cellules, ainsi que le don de gamètes.

L'Établissement français du sang (EFS) est un opérateur civil unique de la transfusion sanguine. Il a pour mission principale l'autosuffisance nationale en produits sanguins. Il s'investit également dans de nombreuses activités, comme les analyses de biologie médicale (en réalisant différents types d'analyses biologiques, hématologiques et immunologiques, examens indispensables dans le cadre d'une transfusion mais également d'une greffe d'organe, de tissus ou de cellules), mais également la thérapie cellulaire et tissulaire ou la recherche (dans les domaines de pointe comme l'ingénierie cellulaire et tissulaire, l'interface immunologique entre donneur et receveur, ou le développement de nouvelles technologies de dépistage et de prévention des risques microbiologiques).

d) Les régimes d'assurance maladie

Voir [point IV](#).

e) Les ordres et syndicats de professionnels de santé

Sept catégories de professionnels de santé sont regroupés au sein d'un ordre professionnel : médecins, pharmaciens, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues. Ces ordres sont des organismes à caractère corporatif institués par la loi. Ils remplissent une fonction de représentation de la profession mais également une mission de service public en participant à la réglementation de l'activité et en jouant le rôle de juridiction disciplinaire pour ses membres. L'appartenance à l'ordre de sa profession est obligatoire pour pouvoir exercer.

Les ordres professionnels sont donc des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public. Ils exercent un double rôle :

- vis-à-vis de l'État, l'ordre représente la profession. Il peut à ce titre être saisi par les autorités étatiques de tout projet de réforme de l'organisation ou du fonctionnement de la profession ;
- vis-à-vis de la profession, l'ordre a pour tâche essentielle de faire respecter une certaine discipline intérieure.

Pour mener à bien cette mission de service public, ils disposent de prérogatives de puissance publique, leur permettant d'exercer 2 compétences :

- administrative/réglementaire : ils édictent certaines règles d'exercice de la profession. Ils peuvent par exemple édicter des codes de conduite ou de déontologie énonçant les devoirs des professionnels. Ce sont les conseils supérieurs de chaque ordre qui sont chargés de cette fonction. Par ailleurs, ils contrôlent l'inscription au tableau de l'ordre, c'est-à-dire l'entrée et l'avancement dans la profession. Ils peuvent également autoriser divers aspects de la vie de la profession, tels que les remplacements de confrères, l'ouverture ou le maintien de cabinets médicaux secondaires, etc.
- compétence disciplinaire/répressive : ils peuvent condamner les membres de la profession coupables de fautes personnelles. Ils agissent alors en tant que juridictions ordinaires.

Les syndicats sont chargés des négociations entre les professionnels de santé et l'Assurance maladie concernant les honoraires et toutes questions relatives à la pratique médicale.

f) Les bénéficiaires du système de santé, via les associations de patients

Les associations de patients font partie des personnalités qualifiées participant au conseil de surveillance des établissements de santé. Le rôle de cette structure est centré sur les orientations stratégiques et le contrôle permanent de la gestion des établissements. Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément, subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit.

II. L'organisation des soins

a) La santé publique

Au niveau national, [Santé publique France](#) est un centre de référence en santé publique, agence d'expertise scientifique, sous tutelle de l'État. Elle a pour mission d'améliorer et de protéger la santé des populations. Cette mission s'articule autour de 3 axes majeurs :

- assurer la mise en œuvre d'un système national de veille et de surveillance afin de détecter et d'anticiper les risques sanitaires et d'apporter les éléments de décision à la puissance publique ;
- améliorer la connaissance sur l'état de santé de la population, les comportements, les risques pour la santé et concevoir les stratégies d'intervention en prévention et promotion de la santé ;
- promouvoir la santé, agir sur les environnements, expérimenter et mettre en œuvre les programmes de prévention, répondre aux crises sanitaires.

En tant qu'agence scientifique et d'expertise du champ sanitaire, Santé publique France a en charge :

- l'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ;
- la veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;

- le lancement de l'alerte sanitaire ;
- la promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;
- le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ;
- la préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires.

Au niveau municipal, des structures de prévention mettent en œuvre les directives nationales en matière de santé publique notamment :

- les services de santé au travail,
- les service de médecine scolaire,
- les services de vaccination,
- les services de protection maternelle et infantile (PMI) assurant des soins prénataux ou postnataux,
- les structures de dépistage des maladies non transmissibles (cancer) ou transmissibles (Sida, hépatites).

Les municipalités sont légalement responsables de la surveillance et de la purification de l'approvisionnement en eau, du contrôle de la pollution atmosphérique et sonore, de l'élimination des déchets, de la protection contre les radiations, de l'hygiène dans les zones résidentielles, de l'hygiène alimentaire et de l'hygiène industrielle.

b) Les soins ambulatoires primaires et spécialisés

Les soins ambulatoires (ou soins de ville) sont les soins effectués en cabinets de ville, dispensaires, centres de soins, lors de consultations externes d'hôpitaux publics ou privés, en cures thermales et les actes d'analyse en laboratoire. Ils sont dispensés par les médecins, dentistes et auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes) dans le cadre de leur activité libérale.

Les offreurs de soins et les producteurs de biens et services en santé regroupent :

- **des professions médicales et pharmaceutiques** (médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes), des auxiliaires médicaux (infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, etc.) aux statuts et aux modes d'exercices divers : libéraux, salariés ou mixtes ;
- **des réseaux de santé pluridisciplinaires (maisons de santé pluridisciplinaires ou MSP, communautés professionnelles territoriales de santé ou CPTS)** intégrant médecins, infirmières et d'autres professionnels (travailleurs sociaux, personnel administratif, etc.) constitués pour favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge et exerçant dans des maisons ou centres de santé.

Les professionnels de santé travaillant au sein de ces structures sont essentiellement chargés de soins de premier recours et de la prévention. Ils doivent élaborer un projet de santé attestant de leur exercice coordonné. Les maisons de santé sont appelées à conclure avec l'agence régionale de santé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens préalablement à tout versement d'une aide financière par l'agence.

Les communautés professionnelles territoriales de santé (**CPTS**) sont constituées de l'ensemble des acteurs de santé (professionnels de santé de ville, qu'ils exercent à titre libéral ou salarié, des établissements de santé, des acteurs de la prévention ou promotion de la santé, des établissements et services médico-sociaux, sociaux...) qui souhaitent se coordonner sur un territoire, pour répondre à une ou plusieurs problématiques en matière de santé qu'ils ont identifiées. Le projet de santé est un pré-requis à la contractualisation entre les professionnels et l'ARS.

La mise en place le parcours de soins coordonnés a imposé à chaque assuré social de plus de 16 ans de désigner un médecin traitant à sa caisse d'assurance maladie. Le médecin traitant intervient en tant que contrôleur de l'accès aux soins. Il est le premier interlocuteur du patient et, le cas échéant, oriente ce dernier vers d'autres professionnels de santé (médecin spécialiste, médecin hospitalier, etc.). Il coordonne l'ensemble des soins et centralise toutes les informations sur les soins prodigués au patient et son état de santé (gestion du dossier médical).

Le choix du médecin traitant est libre. Il peut s'agir d'un médecin généraliste ou d'un médecin spécialiste, choisi sans restriction géographique. L'assuré peut changer de médecin traitant à tout moment. Si le patient ne respecte pas le parcours de soins coordonnés et s'il consulte un médecin spécialiste sans consultation préalable de son médecin traitant, il sera moins bien remboursé par l'Assurance maladie.

Les soins spécialisés sont également dispensés dans les établissements hospitaliers, sous forme de **consultations externes** (ambulatoires), sans hospitalisation et assurées par des praticiens spécialistes. Ces consultations sont délivrées sur le même mode qu'une consultation de ville et sont intégrées au parcours de soins, donc prescrites par les médecins traitants.

c) Les soins hospitaliers

Les établissements de santé couvrent des champs d'intervention différents, (hospitalier ou médico-social), avec des statuts qui peuvent être publics ou privés :

- **des établissements hospitaliers** répartis en plusieurs catégories : établissements publics, établissements privés d'intérêt collectif conventionnés (comme par exemple les hôpitaux privés, les centres de lutte contre le cancer ou de dialyse) et établissements privés à but lucratif. Ils délivrent des soins généraux (médecine, chirurgie, obstétrique) et/ou plus spécialisés (psychiatrie et santé mentale) en assurant le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes ;

- ils concourent à la médecine d'urgence avec, répartis sur tout le territoire, des services d'urgence, des services d'aide médicale urgente (SAMU) pour la régulation, et des services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) pour les interventions ;
 - ils mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé ;
 - ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile ;
 - ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux ;
 - ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ;
 - ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la prise en charge médicale ;
 - ils peuvent développer des alternatives à l'hospitalisation qui ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Parmi ces alternatives : la chirurgie ambulatoire, la télémedecine (téléconsultation, téléexpertise ou télésurveillance, par exemple), l'hospitalisation à domicile, les services de soins infirmiers à domicile, l'accueil temporaire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
 - ils mettent en œuvre une politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et à traiter les événements indésirables liés à leurs activités ;
 - ils prennent en charge l'enseignement et la formation professionnelle ainsi que la recherche scientifique et médicale (hôpitaux publics).
- **Les groupements hospitaliers de territoires (GHT)** sont un dispositif conventionnel, obligatoire depuis juillet 2016, entre établissements publics de santé d'un même territoire, par lequel ils s'engagent à se coordonner autour d'une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, formalisée dans un projet médical partagé.
Le principe est d'inciter les établissements de santé à mutualiser leurs équipes médicales et à répartir les activités de façon à ce que chaque structure trouve son positionnement dans la région. Les GHT organisent la complémentarité des établissements de santé, en prenant en compte la spécificité de chacun dans la construction de l'offre de soins. Ils permettent de mieux organiser les prises en charge, territoire par territoire, et de présenter un projet médical répondant aux besoins de la population.
Il s'agit, à travers l'élaboration d'un projet médical partagé, de favoriser l'émergence de filières de soins territorialisées et d'organiser la gradation de l'offre de soins, afin de garantir une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité.
L'objectif est de garantir à tous les patients un meilleur accès aux soins en renforçant la coopération entre hôpitaux publics autour d'un projet médical.

d) Les soins d'urgence

Les services d'aide médicale urgente (SAMU) situés dans les hôpitaux et la permanence des soins assurent les soins préhospitaliers d'urgence. Le SAMU est accessible gratuitement sur tout le territoire national à partir de n'importe quel téléphone en composant le 15. Les centres partagent les informations avec les centres d'appel d'urgence de la police (17) et des pompiers (18), afin que les urgences médicales soient traitées de manière appropriée. De même, les centres d'appels médicaux ou de pompiers répondent au numéro d'urgence européen 112.

Les appels d'urgence qui parviennent au centre d'appel médical sont traités par des réceptionnistes spécialisés qui sont supervisés et soutenus par des médecins. Les mesures prises dépendent du niveau d'urgence. Si les premiers secours sont nécessaires sur place, les centres d'appel d'urgence médicale peuvent envoyer une unité mobile de soins intensifs (services mobiles d'urgence et de réanimation ou SMUR), une équipe de premiers secours des pompiers ou un médecin généraliste de garde. Sinon, il est conseillé au patient de se rendre en ambulance à l'hôpital d'urgence le plus proche si nécessaire. Le système de continuité des soins est conçu pour apporter une réponse rapide et appropriée aux besoins des patients la nuit et les week-ends ou jours fériés lorsque les cabinets de médecine ambulatoire sont fermés.

À leur arrivée à l'hôpital, les patients en situation d'urgence sont pris en charge dans un service dédié, appelé communément « service d'urgences », chargé d'accueillir 24 heures sur 24 toute personne en situation d'urgence réelle ou ressentie, sans sélection, ce service hospitalier faisant partie des structures d'orientation et de tri des patients.

L'arrivée aux urgences peut se faire de deux manières :

- soit le patient y est acheminé par un SMUR, les sapeurs-pompiers ou un ambulancier privé ;
- soit le patient s'y rend par ses propres moyens – en étant éventuellement envoyé par un médecin de ville.

Les services d'urgence assurent l'accueil, l'orientation et, dans certains cas, le traitement du patient sans distinguer pathologie médicale, chirurgicale ou psychiatrique. Toute personne se présentant aux urgences doit faire l'objet d'une consultation.

Pour remplir leur mission, les services d'urgence disposent :

- d'une zone d'accueil et d'orientation où s'effectue le tri des patients ;

- d'une salle d'accueil des urgences vitales où sont soignées les personnes présentant une urgence vitale ;
- d'une zone de consultation ;
- d'une salle d'observation, où les patients attendent les résultats de leurs examens qui détermineront leur orientation future au sein du parcours de soins ;
- d'une unité d'hospitalisation de courte durée, dans laquelle le patient ne peut rester plus de 24 heures. Le patient doit ainsi être transféré au plus vite vers le service spécialisé requis. La coordination avec les autres services de l'établissement des lits disponibles en aval est donc indispensable.

e) Les soins de longue durée

Les établissements médico-sociaux regroupent, entre autres, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les structures pour personnes atteintes d'un handicap.

Ils ont pour mission d'apporter un accompagnement et une prise en charge aux publics dits « fragiles », en situation de précarité, d'exclusion, de handicap ou de dépendance. Leurs missions d'intérêt général et d'utilité sociale sont les suivantes :

- évaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux : (information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation) ;
- protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes atteintes d'un handicap, des personnes âgées ou en difficulté ;
- actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;
- actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ;
- actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;
- actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique.

Les soins résidentiels ou temporaires pour les personnes âgées sont fournis par de nombreuses institutions offrant différents niveaux de service. Il s'agit notamment des foyers logements collectifs (foyers logements) qui offrent une gamme d'installations non médicales (telles que la restauration et la blanchisserie) mais presque aucun soin médical ; des maisons de retraite (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou EHPAD) qui accueillent les personnes âgées mais offrent également des soins médicaux ; des unités de soins de longue durée qui accueillent des personnes dont les soins nécessitent un suivi médical constant pour les personnes très malades et dépendantes ; des services intermédiaires qui accueillent pendant de courtes périodes des personnes âgées fragiles ne vivant pas dans des services résidentiels. Les soins sont dispensés sur une base quotidienne (accueil de jour) ou temporaire (accueil temporaire).

Le financement des institutions résidentielles pour personnes âgées fragiles est actuellement partagé entre l'Assurance maladie qui couvre le coût des soins médicaux, les conseils généraux, qui couvrent le coût des frais personnels liés à la perte d'autonomie et les usagers, qui couvrent principalement le coût du logement et de l'alimentation.

Les soins à domicile : des services de soins intermédiaires fournissent des soins temporaires aux patients dépendants et des services de répit à leurs aidants. Ils favorisent une meilleure intégration et une plus grande autonomie des personnes dépendantes. Les soins à domicile sont principalement fournis par des médecins et des infirmières indépendants et, dans une moindre mesure, par **les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)**, qui prennent en charge des soins de nursing (toilette) ou des actes infirmiers (pansements, distribution des médicaments, injections), soins financés par l'Assurance maladie ou par les **services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD)** qui prennent en charge, dans le cadre de l'aide sociale, les services ménagers et des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires et les actes essentiels de la vie quotidienne (entretien du logement, entretien du linge, préparation des repas, courses, aide à la toilette, aide à l'habillage et au déshabillage).

Les Services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) apportent à la fois un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et des soins infirmiers. Ils regroupent des services qui assurent les missions d'un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les missions d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD). Ils favorisent la coordination des interventions tant autour de la personne accompagnée, qu'auprès des différents acteurs du secteur.

L'évaluation des besoins de la personne donne lieu à l'élaboration d'un projet individualisé d'aide, d'accompagnement et de soins, construit et mis en œuvre dans une démarche conjointe par les personnels de l'aide et du soin à domicile, pour une prise en charge globale plus cohérente.

f) Les pharmacies

Le marché pharmaceutique français comporte 3 composantes distinctes : les médicaments soumis à prescription médicale obligatoire et les médicaments soumis à prescription médicale facultative, qui sont tous deux délivrés principalement par des pharmacies de détail, et les médicaments réservés aux hôpitaux.

La distribution des médicaments est étroitement réglementée, tant pour les grossistes que pour les pharmacies. Les grossistes-répartiteurs ont une mission de service public et sont soumis au contrôle réglementaire de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) en ce qui concerne la gamme de médicaments fournis, le niveau des stocks, les délais de livraison sur des territoires définis ainsi que leurs marges bénéficiaires. Les pharmacies ont un monopole sur la distribution des médicaments délivrés sur ordonnance médicale. En général, les pharmacies de détail doivent être la propriété d'un pharmacien qualifié ou d'un groupe de pharmaciens associés au sein d'une société ; ces pharmaciens ou sociétés ne peuvent pas être propriétaires de plus d'une pharmacie. Le nombre de pharmacies est réglementé par un *numerus clausus* qui tient compte à la fois de l'importance de la population à desservir et de la distance à parcourir jusqu'à la pharmacie la plus proche. Les pharmaciens bénéficient d'incitations financières pour la livraison de médicaments génériques.

La publicité directe aux consommateurs pour les médicaments est soumise à une autorisation préalable. Elle est limitée aux spécialités qui répondent à 3 critères : elles peuvent être délivrées sans ordonnance du médecin, elles ne sont pas couvertes par l'Assurance maladie et aucune restriction sur la publicité n'a été incluse dans l'autorisation de mise sur le marché du produit. Les vaccins sont la seule exception à cette règle.

La vente libre de médicaments sur Internet est autorisée mais seuls les pharmaciens peuvent exercer cette activité, qui doit être directement liée à une pharmacie physique et autorisée par les agences régionales de santé.

Tous les événements indésirables liés à la prise de médicaments doivent être signalés par les médecins, les dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens aux centres régionaux de pharmacovigilance, chargés de procéder aux enquêtes nécessaires et d'informer le fabricant. Les patients et les associations de patients peuvent déclarer directement les effets indésirables. Les déclarations d'effets indésirables validées doivent être communiquées à l'Agence européenne des médicaments dans un délai de 15 jours.

III. Les coordonnées des différents prestataires de santé

- Le site [Annuaire santé](#) est un service de l'Assurance maladie française. Il permet de rechercher selon plusieurs critères (nom, spécialité, localisation, type d'acte) un professionnel de santé (médecin, infirmier, pharmacien...) ou un établissement de soins (hôpital, clinique...) autorisé à exercer en France.
- Le [fichier national des établissements sanitaires et sociaux \(FINESS\)](#) par thème ou lieu géographique.
- Les différents types d'établissements médico-sociaux peuvent être consultés sur le site de la [Caisse nationale de Solidarité pour l'autonomie \(CNSA\)](#).
- Le site élaboré par le Conseil National des Établissements Thermaux (CNETH) www.medecinethermale.fr contient un annuaire des établissements thermaux en France.

IV. Le financement du système de soins

En France, le financement du système de remboursement des frais médicaux est organisé en deux étages principaux : les régimes obligatoires et les régimes complémentaires.

a) Les régimes d'assurance maladie obligatoire de base

Ils sont caractérisés par l'obligation d'adhésion et de cotisation et ils reposent donc sur une solidarité large, basée sur des contributions assises sur les revenus, et un accès aux soins défini selon les besoins.

Les [principaux régimes de sécurité sociale](#) (régime général et régime agricole) sont regroupés au sein de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam) dont le rôle est de :

- conduire la politique conventionnelle qui détermine les liens entre l'Assurance maladie et les professionnels de santé libéraux,
- définir le champ des prestations admises au remboursement,
- fixer le taux de prise en charge des soins.

Les [régimes obligatoires d'assurance maladie](#) concentrent leur intervention en faveur du « gros risque », c'est-à-dire des risques santé qui ont le plus de conséquences sur les revenus des assurés, soit parce que leurs pathologies nécessitent des soins de longue durée et/ou coûteux, soit parce qu'elles mobilisent un plateau technique conséquent tant en termes de matériels, de techniques que de personnels, comme les dépenses réalisées dans les hôpitaux.

b) Les régimes complémentaires (mutuelles, sociétés d'assurances, institutions de prévoyance)

Les régimes complémentaires s'appuient sur une solidarité restreinte au champ des adhérents et offrent des prises en charge variables, définies par le type de contrat souscrit. Ils permettent de couvrir la part des dépenses de soins de santé qui n'est pas prise en charge par le régime de base obligatoire (tickets modérateurs, franchises, forfaits hospitaliers, prises en charge en matière d'optique, d'orthèse ou de matériels...).

Si les assurés ne bénéficient pas d'une couverture complémentaire collective au titre de leur activité, ils peuvent contracter une assurance complémentaire auprès d'une mutuelle, d'une institution de prévoyance ou d'une compagnie d'assurance.

c) Les financeurs publics (État)

Le troisième étage concerne surtout les dépenses de prévention, de recherche médicale et pharmaceutique, de formation des professionnels de santé (médecins, dentistes, pharmaciens, et auxiliaires médicaux), de complémentaire santé solidaire (CSS), de dotations pour les hôpitaux militaires, de soins d'urgence, ainsi que de prestations versées aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'État (AME).

d) Les ménages

Enfin, une part des dépenses peut demeurer à la charge des bénéficiaires de soins.

V. La surveillance des professionnels de santé

a) Les Agences régionales de santé (ARS)

Afin de prévenir les risques, les agences régionales de santé (ARS) assurent d'importantes missions d'inspection-contrôle dans 3 domaines : sécurité sanitaire, fonctionnement des établissements et services, actes médicaux et pratiques des professionnels.

Les inspections-contrôles portent sur les secteurs :

- sécurité sanitaire, prévention des risques et protection de la population (eaux de consommation et de loisirs, habitat, établissements recevant du public, environnement extérieur),
- prévention et promotion de la santé,
- soins ambulatoires,
- soins hospitaliers,
- professions de santé,
- secteur médico-social.

L'objectif est d'articuler les missions d'inspections-contrôles avec les politiques nationales de santé.

La sécurité sanitaire

Il s'agit de tous les risques liés aux activités de soins, aux produits consommés (produits alimentaires et produits de santé) et aux milieux de vie (eau, air, sol).

Les inspections-contrôles menés par les agences concernent :

- les établissements de santé et médico-sociaux (déchets de soins à risque infectieux, légionelles...),
- les cabinets médicaux, les tatoueurs, les établissements recevant du public (amiante, eaux de loisirs, niveaux sonores...),
- les particuliers (habitat, monoxyde de carbone),
- les installations techniques publiques ou privées (captages, réservoirs).

Le fonctionnement des établissements sanitaires et médico-sociaux

Les agences régionales de santé veillent au bon fonctionnement des **établissements et services de santé** ainsi que des **établissements et services médico-sociaux**, en termes d'effectifs, de permanence médicale, de qualification du personnel, etc.

- Dans les établissements de santé, les missions d'inspections-contrôles concernent les conditions d'installation et de fonctionnement des activités de soins (inspection de la réanimation, de la maternité, des urgences, du bloc opératoire, etc.).
- Dans les établissements médico-sociaux, il s'agit de repérer et de prévenir les risques de maltraitance.

Les actes médicaux et les pratiques des professionnels

En partenariat avec l'Assurance maladie, et/ou les Ordres professionnels, les agences régionales mènent des actions de contrôle et de sensibilisation des professionnels de santé autour des thématiques suivantes, liées à la **sécurité, la qualité et la pertinence** des soins :

- les prescriptions médicamenteuses,
- les prescriptions de transports sanitaires,
- la justification médicale des prestations,
- la conformité des pratiques médicales au regard des recommandations de bonnes pratiques diffusées par les agences sanitaires.

b) La Haute Autorité de santé (HAS)

Au titre de sa mission d'accréditation des médecins exerçant en établissements de santé, la Haute Autorité de santé est chargée :

- de recueillir auprès des médecins ou des équipes médicales qui demandent à être accrédités les déclarations des événements considérés comme porteurs de risques médicaux et de procéder à leur analyse ;
- d'élaborer avec les professionnels et les organismes concernés, selon des méthodes scientifiquement reconnues, ou de valider des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles fondés sur des critères multiples ;
- de diffuser ces référentiels et de favoriser leur utilisation par tous moyens appropriés ;

- d'organiser la procédure d'accréditation des médecins ou des équipes médicales au regard des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles ;
- de veiller, par tout moyen approprié, à la validation des méthodes et à la cohérence des initiatives relatives à l'amélioration de la qualité dans le domaine de la prise en charge des patients.

Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée **certification**.

Cette procédure, conduite par la Haute Autorité de santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité d'un établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs pôles, structures internes ou activités d'un établissement, à l'aide d'**indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement**.

c) L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

L'ANSM est l'autorité compétente pour toutes les décisions de sécurité prises concernant les produits de santé, de leur fabrication à leur commercialisation. Elle remplit 4 missions essentielles :

- évaluation scientifique,
- surveillance des laboratoires et réglementation de la publicité,
- inspection des sites industriels,
- information des professionnels de la santé.

Sa compétence s'applique aux **médicaments** (tous les médicaments [avant et après autorisation de mise sur le marché] et matières premières, médicaments dérivés du sang, stupéfiants et psychotropes, vaccins, produits homéopathiques, à base de plantes et de préparations, préparations magistrales et hospitalières), aux **produits biologiques** (organes, tissus, cellules utilisés à des fins thérapeutiques, produits de thérapie cellulaire et génique, produits sanguins labiles et produits thérapeutiques annexes), aux **dispositifs médicaux** (thérapeutiques, de diagnostic, diagnostic in vitro, des plateaux techniques et logiciels médicaux), aux **produits cosmétiques et de tatouage et aux autres produits de santé** (biocides).

L'ANSM développe plusieurs activités en France et pour le compte de l'Union européenne :

- l'évaluation scientifique et technique de la qualité, de l'efficacité et la sécurité d'emploi des médicaments et produits biologiques ;
- la surveillance continue des effets indésirables prévisibles ou inattendus des produits de santé ;
- l'inspection des établissements exerçant des activités de fabrication ; d'importation, de distribution, de pharmacovigilance et qui mènent des essais cliniques ;
- le contrôle des laboratoires pour libérer des lots de vaccins et de médicaments dérivés du sang, le contrôle de produits présents sur le marché, prélevés lors d'inspections, saisis par les autorités judiciaires ou les douanes.

Ces actions débouchent sur la prise de décisions de police sanitaire pour le compte de l'État français :

- autorisation de mise sur le marché (AMM), retrait ou suspension d'AMM
- autorisation d'essais cliniques
- autorisation temporaire d'utilisation (ATU) nominative d'un médicament et ATU de cohorte
- recommandations temporaires d'utilisation de spécialités pharmaceutiques
- libération de lots de vaccins et de produits dérivés du sang
- retrait de produits ou de lots
- interdiction de dispositifs médicaux sur le marché français
- autorisation d'importation
- autorisation préalable ou interdiction de publicité...

L'ANSM développe également l'information des patients, des professionnels de santé, des relais professionnels et sociétés savantes, de la presse.

d) L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

L'ANSES évalue les risques dans l'alimentation, l'environnement et les lieux de travail par la surveillance, l'alerte, la recherche et l'investigation. Ses missions de veille, de vigilance et de surveillance permettent de nourrir l'évaluation des risques. L'Agence évalue ainsi l'ensemble des risques (chimiques, biologiques, physiques...) auxquels un individu peut être exposé, volontairement ou non, à tous les âges et moments de sa vie, qu'il s'agisse d'expositions au travail, pendant ses transports, ses loisirs, ou via son alimentation. L'ANSES assure, par ailleurs, l'évaluation de l'efficacité et des risques des médicaments vétérinaires, des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes, supports de culture et de leurs adjuvants, ainsi que des biocides, afin de délivrer les autorisations de mise sur le marché. Elle réalise également l'évaluation des produits chimiques.

Au niveau national, l'ANSES est responsable de la surveillance de la sécurité au travail et d'assurer la prévention et la protection de la santé des travailleurs.

e) L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

Le domaine d'expertise de l'IRSN couvre l'ensemble des risques liés aux rayonnements ionisants utilisés dans l'industrie et la médecine, ainsi qu'aux rayonnements naturels. L'Institut contribue à la formation en radioprotection des professionnels de santé et des personnes professionnellement exposées. Il participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment en concourant à la surveillance radiologique de l'environnement et en assurant la gestion et l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Il tient l'inventaire des sources de rayonnements ionisants.

